

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **vigilancia de las enfermedades profesionales** es una herramienta fundamental de la **salud pública ocupacional**, cuyo objetivo es identificar, registrar, analizar y prevenir los daños a la salud derivados del trabajo.

En Chile, el marco legal que sustenta esta vigilancia es la **Ley N.º 16.744 (1968)**, que establece el **Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales**, administrado por las **mutualidades de empleadores** y el **Instituto de Seguridad Laboral (ISL)**.

El **médico general**, especialmente en el ámbito de Atención Primaria y Servicios de Urgencia, tiene un papel clave al **detectar casos sospechosos, notificar oportunamente y orientar la derivación y rehabilitación**.

En el **EUNACOM**, este tema es evaluado con frecuencia, ya que combina conocimientos de **epidemiología, normativa sanitaria y clínica aplicada**, reflejando la capacidad del médico para actuar como agente de salud pública.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Enfermedad profesional

De acuerdo con la **Ley 16.744, artículo 7**, se define como:

“Toda enfermedad causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.”

Esto implica que debe existir una **relación causal comprobable** entre la exposición laboral y el daño a la salud.

2.2. Vigilancia epidemiológica ocupacional

Es el conjunto de **acciones sistemáticas y continuas** destinadas a:

- Detectar precozmente casos o exposiciones peligrosas.

- Analizar tendencias de enfermedades y riesgos.
- Evaluar la efectividad de las medidas de prevención.
- Proponer acciones correctivas en el ambiente laboral.

2.3. Tipos de vigilancia

Tipo	Objetivo	Ejemplo
Pasiva	Recepción de notificaciones desde los establecimientos.	Registro SISAL o mutualidades.
Activa	Búsqueda deliberada de casos o exposiciones.	Programas ISP (sílice, plomo, ruido).
Centinela	Monitoreo de eventos específicos en centros seleccionados.	Hospitales con vigilancia de tuberculosis ocupacional.

3. Marco legal y normativo chileno

Instrumento	Año	Institución responsable	Contenido principal
Ley N.º 16.744	1968	SUSESO / MINSAL	Seguro social de accidentes y enfermedades profesionales.
D.S. N.º 109	1968	MINSAL	Reglamento sobre enfermedades profesionales.

D.S. N.º 40	196 9	Ministerio del Trabajo	Normas de prevención de riesgos y comités paritarios.
D.S. N.º 594	199 9	MINSAL	Condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo.
Circular SUSESO N.º 3.456	201 9	SUSESO	Procedimiento de notificación y calificación de enfermedades profesionales.
Resolución Exenta MINSAL N.º 861	202 3	MINSAL / ISP	Actualiza protocolos de vigilancia de agentes específicos (ruido, sílice, plomo, TME, etc.).

4. Sistema de notificación y calificación

4.1. Actores involucrados

1. **Médico tratante:** identifica y notifica el caso sospechoso.
 2. **Empleador:** informa al organismo administrador (mutualidad o ISL).
 3. **Organismo administrador (OA):** evalúa la exposición, confirma diagnóstico y determina origen laboral.
 4. **SUSESO:** supervisa y resuelve apelaciones.
 5. **ISP:** coordina vigilancia ambiental y biomédica de agentes ocupacionales.
-

4.2. Procedimiento de notificación

1. **Sospecha médica:**
 - Basada en historia laboral compatible y síntomas clínicos relacionados con el trabajo.

2. Formulario de notificación:

- **“Formulario de Enfermedad Profesional (FEP)”**, enviado al organismo administrador (ISL o mutualidad).

3. Evaluación técnica:

- Estudio ambiental y médico ocupacional.
- Análisis de exposición mediante dosimetría, medición de contaminantes o análisis biológicos.

4. Determinación del origen:

- **Laboral:** se otorga cobertura bajo la Ley 16.744.
- **Común:** se deriva al sistema previsional general (FONASA o ISAPRE).

5. Registro nacional:

- Incorporación al **Sistema de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISAL)**.

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

La confirmación de una enfermedad profesional requiere:

1. **Historia ocupacional completa:** tipo de tarea, tiempo de exposición, uso de EPP.
2. **Confirmación clínica:** diagnóstico médico según guías del MINSAL o ISP.
3. **Pruebas ambientales:** medición de contaminantes, ruido o agentes biológicos.
4. **Evaluación pericial:** realizada por médicos del OA o SUSESO.

5.1. Ejemplos de enfermedades bajo vigilancia en Chile

Agente / Riesgo	Enfermedad asociada	Programa de vigilancia ISP
-----------------	---------------------	----------------------------

Sílice	Silicosis	Programa de vigilancia del sílice (DS 594, art. 95)
Ruido	Hipoacusia laboral	Programa nacional de ruido ocupacional
Plomo	Intoxicación crónica por plomo	Programa de exposición a plomo
Movimientos repetitivos	Trastornos músculo-esqueléticos (TME)	Vigilancia de TME (2021)
Asbesto	Asbestosis, cáncer pulmonar	Programa nacional de erradicación del asbesto
Agentes biológicos	Tuberculosis, brucelosis, COVID-19	Vigilancia de riesgo biológico en salud

6. Función del médico general en la vigilancia ocupacional

Rol	Descripción	Ejemplo práctico
Pesquisador precoz	Identifica síntomas sugestivos de origen laboral.	Tos crónica en minero → sospecha de silicosis.
Notificador obligatorio	Informa casos sospechosos al OA.	Uso del formulario FEP.

Educador sanitario	Promueve conductas seguras en trabajadores.	Charlas en APS o empresas.
Evaluador del entorno familiar y comunitario	Detecta riesgos domésticos derivados del trabajo.	Exposición secundaria al plomo en hijos de trabajadores.
Articulador intersectorial	Coordina acciones con municipios, ISP y mutualidades.	Campañas locales de salud ocupacional.

7. Estrategias de prevención y vigilancia

7.1. Prevención primaria

- Control ambiental (ventilación, filtros, cabinas).
- Sustitución de sustancias tóxicas.
- Capacitación y uso de EPP.
- Fiscalización de las condiciones de trabajo por SEREMI de Salud.

7.2. Prevención secundaria

- Exámenes de vigilancia médica periódica.
- Evaluaciones audiométricas, espirometrías, biomonitoreo (plomo, sílice, etc.).
- Registro sistemático de exposición.

7.3. Prevención terciaria

- Rehabilitación y reinserción laboral.
- Reubicación en tareas seguras.

- Evaluación de incapacidad y compensación económica.

8. Indicadores de vigilancia y desempeño

Indicador	Descripción	Fuente
Tasa de incidencia de enfermedad profesional	Casos nuevos por 100.000 trabajadores/año	SISAL – SUSESO
Cobertura de vigilancia médica	% de trabajadores expuestos con control anual	ISP
Cumplimiento de medidas preventivas	% de empresas con controles ambientales certificados	SEREMI
Tasa de notificación oportuna	% de casos notificados dentro de 48 h	MINSAL

9. Situación actual en Chile (2024–2025)

- **Enfermedades profesionales más notificadas:** hipoacusia, silicosis, TME, dermatitis de contacto y estrés laboral.
 - **Tendencias emergentes:** enfermedades musculoesqueléticas y mentales por teletrabajo y sobrecarga digital.
 - **Subnotificación estimada:** hasta el **60 %** de los casos, especialmente en microempresas y trabajo informal.
 - **Enfoque ministerial actual:** fortalecer la **vigilancia integrada** entre salud, trabajo y medio ambiente.
-

10. Errores comunes en EUNACOM

Error frecuente	Corrección conceptual
No notificar un caso sospechoso por falta de certeza diagnóstica	La notificación debe realizarse ante sospecha razonable , no confirmación.
Pensar que la vigilancia es exclusiva de mutualidades	El MINSAL e ISP también tienen funciones de vigilancia epidemiológica.
No diferenciar enfermedad profesional de accidente	La primera es crónica o gradual; el accidente, súbito.
Ignorar el rol del médico general en APS	Todo médico tratante tiene obligación legal de notificar.
Creer que las medidas preventivas son responsabilidad exclusiva del empleador	Son compartidas entre empleador, trabajadores y servicios de salud.

11. Complicaciones y desafíos

- **Subnotificación persistente**, especialmente en sectores agrícolas, domésticos e informales.
- **Escasa integración intersectorial** entre salud, trabajo y medio ambiente.
- **Déficit en recursos humanos especializados** en medicina del trabajo.
- **Emergencia de riesgos nuevos**: nanotecnología, radiación UV, estrés térmico y digitalización.

Pronóstico:

El fortalecimiento de la vigilancia ocupacional en Chile avanzará hacia un **sistema digital unificado (SISAL 2.0)**, con integración del **ISP, SUSESO y MINSAL**, ampliando el enfoque hacia el **trabajo digno y saludable** según los principios de la **Agenda OIT 2030**.

12. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2024). Programa Nacional de Salud del Trabajador.
- SUSESO (2023). Informe Anual sobre Enfermedades Profesionales.
- ISP (2023). Protocolos de vigilancia de exposición ocupacional.
- Ley N.º 16.744 (1968). Diario Oficial.
- OIT (2022). Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **vigilancia de enfermedades profesionales** busca detectar precozmente daños derivados del trabajo y prevenir nuevos casos.
2. En Chile, está regulada por la **Ley 16.744** y sus reglamentos asociados.
3. Todo **médico tratante tiene obligación de notificar** casos sospechosos al organismo administrador.
4. Los **principales programas de vigilancia** se centran en sílice, ruido, plomo, TME y agentes biológicos.
5. La **subnotificación** sigue siendo un problema crítico en salud ocupacional.
6. La **vigilancia médica y ambiental integrada** es esencial para prevenir discapacidad laboral y proteger la salud de los trabajadores.
7. El **médico general en APS** cumple un rol fundamental en la detección, notificación y educación preventiva.